

LAPORAN ANALISIS KESELURUHAN SKRINING KEHAMILAN

Sistem Monitoring Kehamilan Berdasarkan Skoring Poedji Rochjati (KRR, KRT, KRST)

1. Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan hasil analisis komprehensif terhadap **504 data ibu hamil** di wilayah kerja binaan (Lebak Wangi dan Perum Duta Asri). Berdasarkan sistem skoring Poedji Rochjati, ditemukan bahwa **429 ibu hamil (85.1%)** berada dalam kategori kehamilan berisiko (KRT dan KRST), sedangkan hanya **75 ibu hamil (14.9%)** yang tergolong dalam Kehamilan Risiko Rendah (KRR). Tingginya proporsi kehamilan berisiko menuntut pengawasan klinis ketat, pemenuhan skrining USG ANC terpadu, serta kesiapan sistem Rujukan Dini Berencana (RDB) ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL/RS PONEK).

2. Distribusi Kategori Risiko (Poedji Rochjati)

Kategori Risiko	Rentang Skor PR	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Rekomendasi Tempat & Penolong Bersalin
KRR (Risiko Rendah)	Skor = 2	75	14.9%	Bidan di Polindes, Puskesmas, atau BPM Mandiri
KRT (Risiko Tinggi)	Skor 6 - 10	329	65.3%	Bidan didampingi Dokter di Puskesmas / Rujukan Terencana RS
KRST (Risiko Sgt Tinggi)	Skor ≥ 12 (Maks 22)	100	19.8%	Wajib di Rumah Sakit PONEK bersama Dokter Spesialis Obgyn
TOTAL	-	504	100.0%	-

3. Faktor Risiko Klinis & Komorbiditas Dominan

Faktor Risiko / Komplikasi	Jumlah Kasus	Prevalensi (%)	Dampak & Catatan Klinis
Tekanan Darah Tinggi / Hipertensi (≥140/90 mmHg)	239	47.4%	Faktor risiko tertinggi preeklamsia berat, solusio plasenta, dan IUGR.
Usia Rentan Reproduksi (<20 th atau ≥35 th)	207	41.1%	Usia muda berisiko panggul sempit; usia tua rentan komplikasi metabolik/kromosom.
Risiko Panggul Sempit (Tinggi Badan <145 cm)	90	17.9%	Potensi disproporsi kepala panggul (CPD) yang memicu partus macet.
Riwayat Bekas Operasi Caesar (SC)	98	19.4%	Risiko ruptur uteri; evaluasi ketebalan SBR di Trimester 3 wajib dilakukan.

- **Riwayat Penyakit Terbanyak:** Anemia (63 kasus), Hipertensi (60 kasus), Asthma (53 kasus), Gastritis (48 kasus), Diabetes (47 kasus).
- **Riwayat Alergi Terbanyak:** Dingin (58 kasus), Penisilin (51 kasus), Seafood (49 kasus), Udang (46 kasus), Debu (42 kasus) (Perhatian khusus alergi Penisilin pada pemberian profilaksis persalinan).

4. Rekomendasi Tindak Lanjut Program Kesehatan Ibu

- **Bagi Kader Posyandu:** Pemasangan stiker P4K di rumah seluruh ibu hamil, pendampingan kepatuhan konsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) dan kalsium, serta pemantauan donor darah keluarga siaga.
- **Bagi Bidan & Puskesmas:** Penguatan skrining preeklamsia terpadu (pemeriksaan tensi berkala & protein urine) pada 202 ibu bertekanan darah tinggi. Koordinasi Rujukan Dini Berencana (RDB) bagi 100 ibu hamil KRST sebelum timbul tanda inpartu.
- **Bagi Rumah Sakit Rujukan (PONEK):** Kesiapsiagaan fasilitas penanganan gawat darurat obstetri neonatal 24 jam, ketersediaan darah, dan penjadwalan persalinan terencana pada kasus bekas SC dan disproporsi panggul.
- **Integrasi Chatbot AI BumilCare:** Pemanfaatan asisten digital terintegrasi untuk mendukung konsultasi harian kader dan bidan dalam menjawab pertanyaan seputar skrining risiko dan pencegahan komplikasi.

Mengetahui,
Koordinator Bidan Puskesmas

Disusun Oleh,
Tim Analis MaternalCare

NIP.

Tanggal: September 2026